

间歇性自我导尿 (ISC)

患者须知 · 使用细导尿管自行排空膀胱

WARWIKI

间歇性自我导尿（ISC）是一种自行排空膀胱的方法：将一根细软导尿管轻柔插入，引流尿液后取出 — 每天操作数次。适用于膀胱无法自行充分排空的情况。学会后仅需几分钟，可以让您恢复自由生活，同时保护肾脏功能。

为什么需要进行ISC

若膀胱无法完全排空 — 可能因某些手术后、**神经源性膀胱**、脱垂或出口梗阻所致 — 残余尿会引起感染、尿漏，并对肾脏造成压力损害。ISC **按计划完全排空膀胱**，从而解决上述问题。

ISC优于留置导尿管的原因

- 与留置导尿管相比，**感染风险更低**
- **无需尿袋**，导尿间期无需携带任何装置，生活更自由
- 对膀胱和肾脏的长期保护效果更佳

初学时可能感到紧张，但大多数人 — 及其照护者 — 在护士指导下都能快速掌握。

名词解释

ISC

间歇性自我导尿 — 自行将导尿管插入膀胱引流尿液后取出。

导尿管

插入膀胱以引流尿液的细软管。

残余尿

排尿后膀胱内残留的尿液。

神经源性膀胱

因神经系统疾病导致膀胱功能异常。

清洁操作

洗手并清洁相关部位 — 清洁即可，无需完全无菌。

留置导尿管

持续保留在体内并连接尿袋的导尿管（ISC可避免使用）。

会疼吗？ 通常不疼 — 大多数人只感到轻微压迫感，现代导尿管均预润滑且管径极细。最初几次可能有轻微不适或少量点状出血。护士会一步步指导您，直至您能独立、熟练地操作。

操作过程（清洁操作）

- 1 **洗手**并备齐用品；清洁尿道口。
- 2 **轻柔插入**已润滑的导尿管，直至尿液流出后再稍微推进一点。
- 3 待膀胱**完全引流**后，缓慢取出导尿管。
- 4 **丢弃**一次性导尿管（或按指导清洁可重复使用的导尿管），再次洗手。

导尿频率

- 通常**每4–6小时一次**（每天约4–6次）— 具体安排由您的医疗团队制定。
- 不要跳过 — 规律导尿可防止膀胱过度充盈和感染。
- 正常饮水；如医嘱要求，记录尿量。

注意事项

- 在任何清洁的卫生间均可操作；用品携带方便、不显眼。
- 尿液轻微混浊或存在少量细菌是常见现象 — 尿路感染（UTI）仅在出现**症状**时才需治疗。
- 若您无法自行操作，可由照护者学习协助完成。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **无法插入导尿管**，或感觉膀胱胀满但引流出极少或无尿液
- 发热、寒战或腰背部/侧腹疼痛（可能为感染）
- 持续**出血**或明显疼痛

需要记住的三件事

1. ISC可排空无法自行排空的膀胱 — 保护肾脏，预防感染和尿漏。
2. 按规律时间表（通常每4–6小时）进行清洁操作；护士将指导您直至熟练掌握。
3. 通常无痛，且比留置导尿管更安全。如无法插管、无法排空或出现发热，请及时联系医疗团队。